



CBMS 2026

CONGRÈS INTERNATIONAL DE BIOLOGIE MÉDICALE

24 & 25 OCTOBRE 2026 | SÉTIF, ALGÉRIE



Maladies auto-immunes associées à la cholangite biliaire primitive

E.BOUACHA¹, N.BENACHOUR¹

¹ Service d'Immunologie, CHU Constantine, Algérie.

INTRODUCTION

En raison de sa pathogénie auto-immune, la cholangite biliaire primitive (CBP) s'associe fréquemment à d'autres maladies de même nature, justifiant la tendance actuelle vers un dépistage systématique. L'objectif de notre étude est de déterminer la prévalence et la nature de ces pathologies associées.

MATÉRIELS ET MÉTHODES

Nous avons étudié de façon rétrospective les dossiers de 20 patients consécutifs atteints d'une CBP diagnostiqués selon les recommandations de l'European Association for the study of the liver (EASL, 2018) et ayant bénéficié à notre niveau d'un bilan immunologique, entre janvier 2024 et août 2025.

La détection des anticorps anti-tissus a été réalisée dans l'unité d'auto-immunité de service d'immunologie du CHU Constantine, par immunofluorescence indirecte (IFI) sur coupe de tissus foie/estomac/rien de rat (Euroimmun), ainsi que la recherche d'anticorps antinucléaires sur frottis de cellules HEp2 (Euroimmun). La détermination des spécificités antigéniques ainsi que la confirmation de la présence des anticorps anti-AMA2 (AMA M2, M2-3E, Sp100, PML, gp210, LKM-1, LC-1, SLA/LP, Ro-52) ont été réalisées par immunodot (EUROLINE Autoimmune/Liver Diseases IgG).

RÉSULTATS ET DISCUSSION

-Tous nos malades étaient de sexe féminin (Fig.1), avec un âge moyen de 49,16 ans [26–77]. Les patientes présentant une CBP associée à au moins une autre maladie auto-immune étaient au nombre de 5 (25 %)(Fig.2).

-La découverte de ces maladies auto-immunes précédait celle de la CBP dans 4 cas (20 %), il s'agissait d'un lupus érythémateux disséminé dans 1 cas, une sclérodermie dans 1 cas, une maladie cœliaque dans 1 cas et une association entre un syndrome de Gougerot-Sjögren et une polyarthrite rhumatoïde dans 1 cas. (Fig.3)

-D'un autre côté cette découverte était concomitante, grâce à un dépistage systématique, dans 1 cas (5%), une hépatite auto-immune était retrouvée chez cette patiente, définissant ainsi un syndrome de chevauchement. (Fig.3)

-L'association de la CBP avec chacune de ces maladies a été rapportée par plusieurs études dans la littérature avec des prévalences variables :

-Mrabet S et al ont trouvé une association avec le Lupus (un cas) et la sclérodermie (un cas) dans une étude rétrospective étalée sur une période de 18 ans regroupant un total de 57 cas de CBP [1].

-Une association à une maladie cœliaque (un cas) , au syndrome de Gougerot-Sjogren (5 cas) et a la PR (1cas) ,ont été également rapporté par Hasnaoui et collaborateurs dans une étude rétrospective concernant 71 cas de CBP, colligés sur une période de douze ans [2].

-Bien que la CBP puisse être responsable d'arthralgies par elle-même ; la survenue de polyarthrite ou de synovite, manifestations de la polyarthrite rhumatoïde restent exceptionnelles, comme l'a rapporté Chouqui et al. [3] et Gu et al. [4]

-Enfin L'association avec l'hépatite auto-immune est l'association la plus commune selon les études de Mrabet et al (14 cas/33). [1] et de Hasnaoui et al (20 cas/36). [2]. Ainsi, l'HAi peut s'associer à une CBP soit simultanément soit consécutivement.

- En plus de ce qu'on a trouvé comme maladies associées a la CBP d'autres maladies ont été rapporté par plusieurs auteurs comme la thyroïdite d'Hashimoto (11 cas/33), le diabète insulino-dépendant (2 cas /33) et l'anémie de Biermer (1 cas/33) [1] .

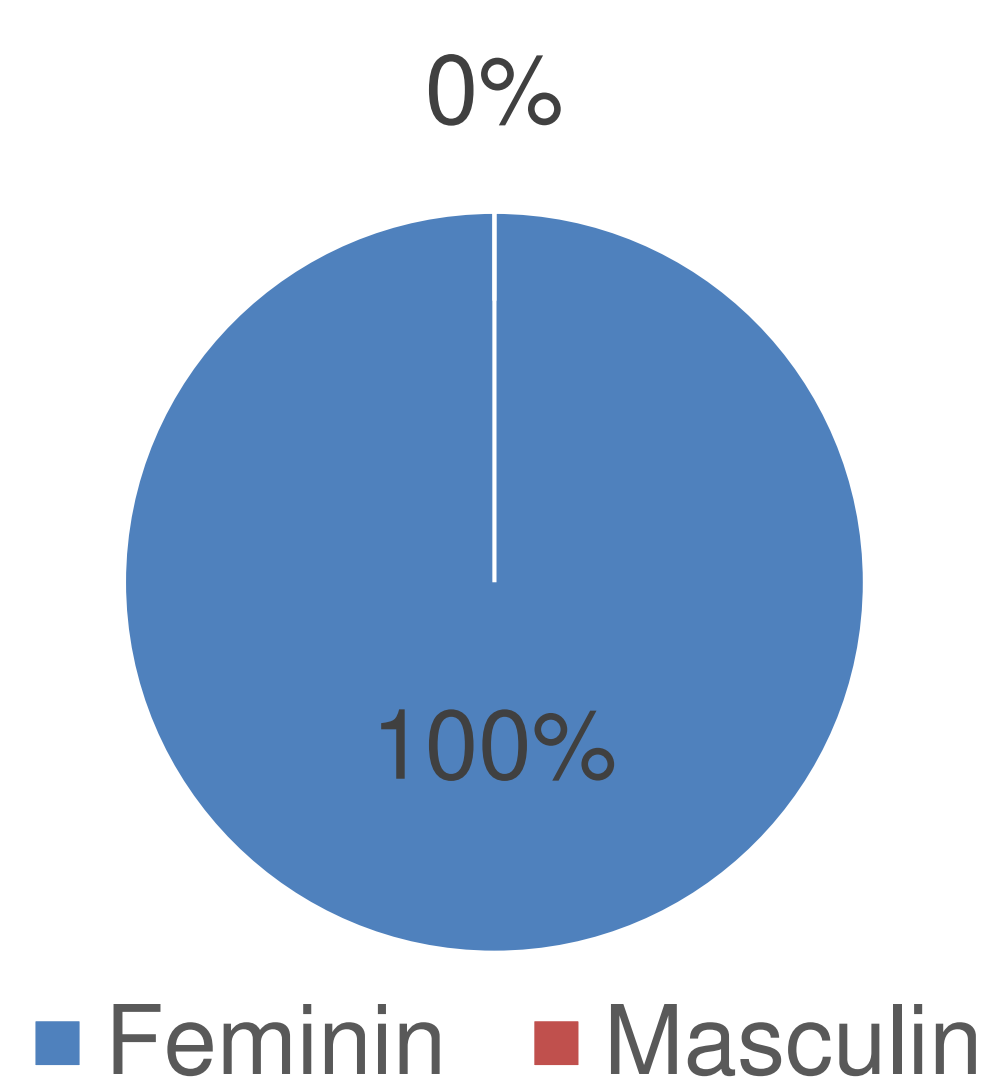


Fig.1: Répartition de la totalité des cas selon le sexe

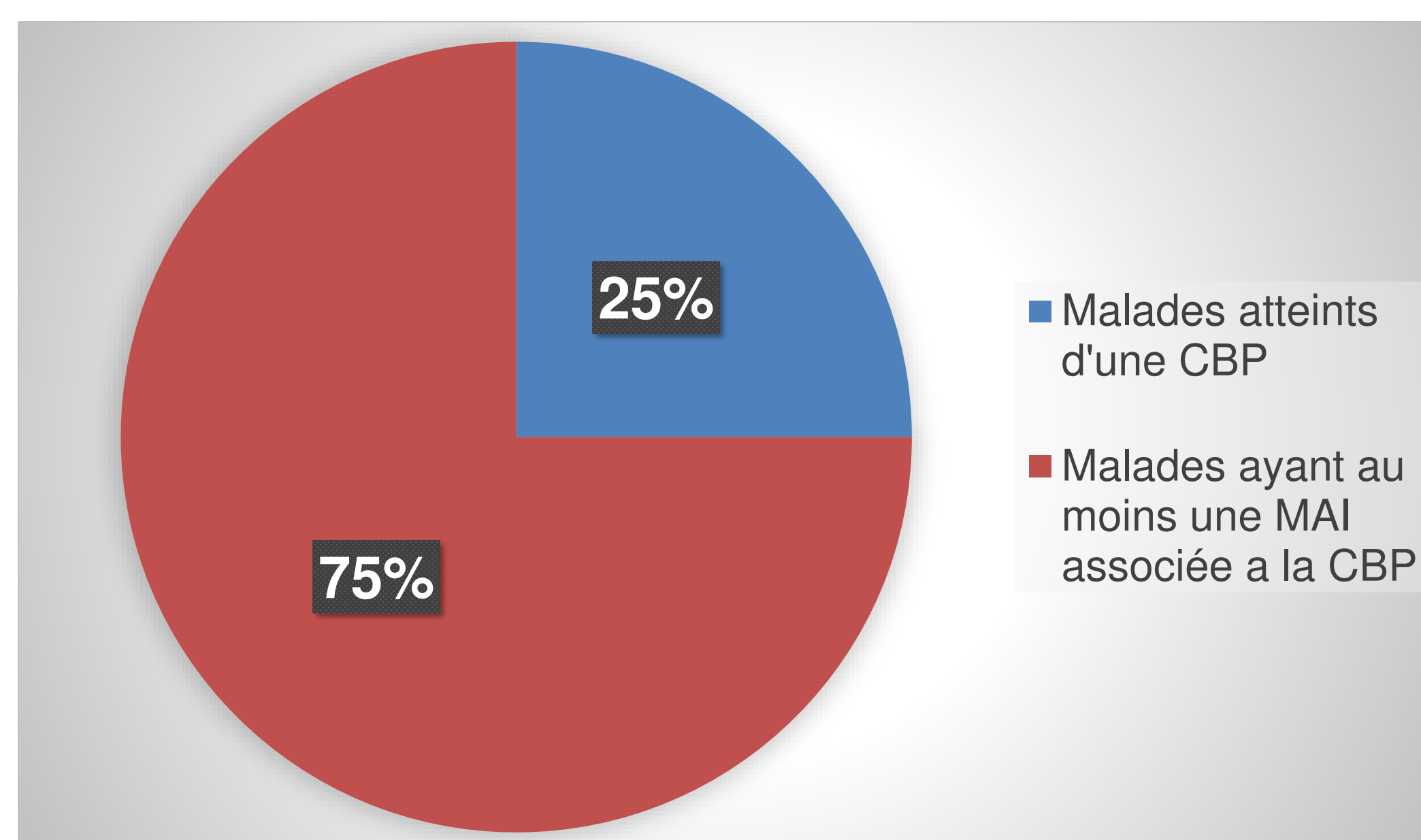


Fig.2: Pourcentage des patients atteints d'une CBP et ayant au moins une MAI associée.

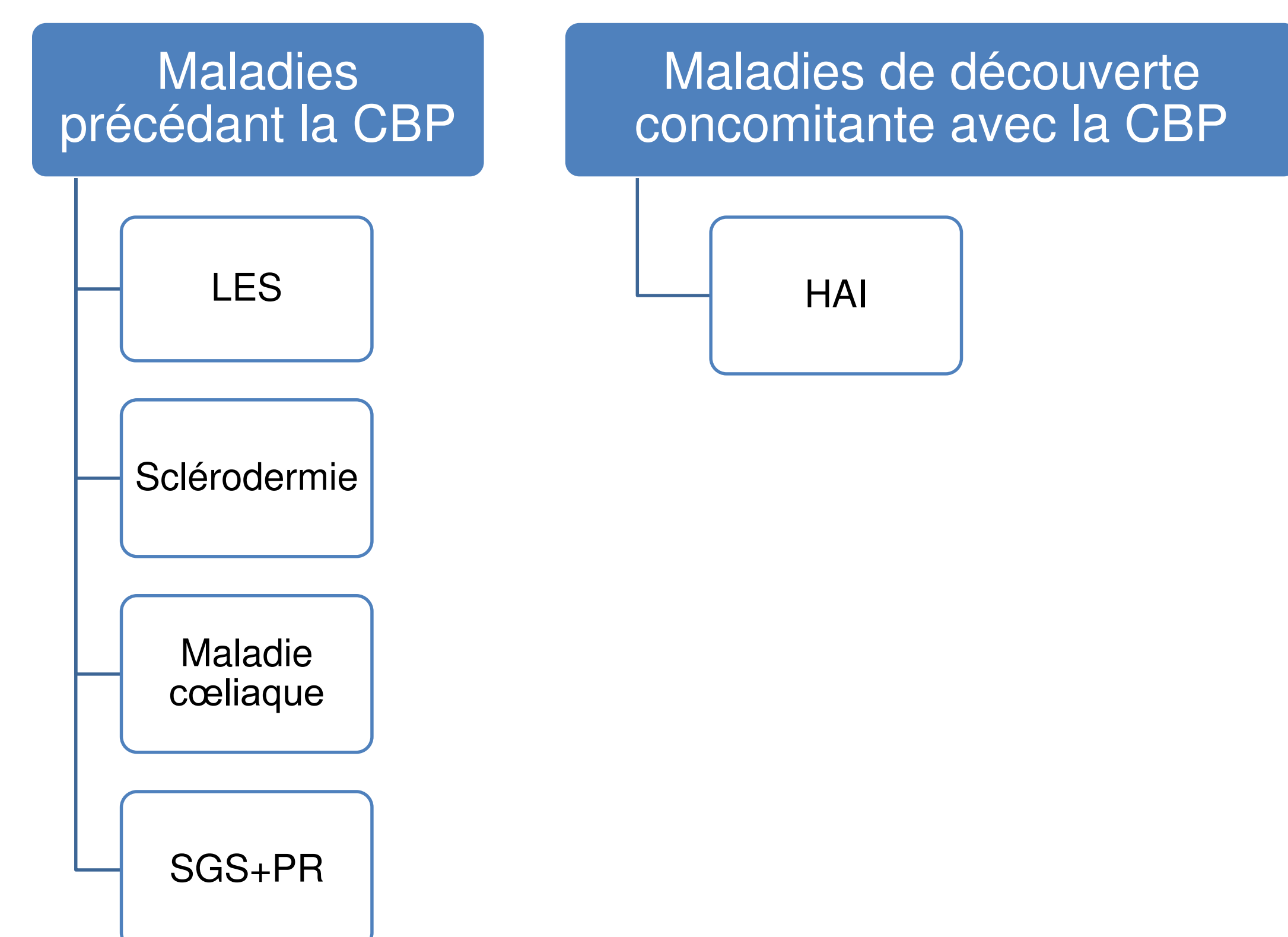


Fig.3: Maladies auto-immunes retrouvées en association avec la CBP

CONCLUSION

- La fréquence non négligeable des associations de la CBP avec d'autres maladies auto-immunes justifie un dépistage systématique et un suivi multidisciplinaire afin d'éviter tout retard diagnostique et thérapeutique..

Bibliographies:

- [1] Mrabet S, Akkari I, Ben Jazia E Gastroentérologie, CHU Farhat-Hached, Sousse, Tunisie Maladies auto-immunes associées à la cholangite biliaire primitive : prévalence et impact pronostique. Rev Med Interne 2018 p: A118–A252.
- [2] Hasnaoui B, Hammami A, Ksiai M, Elleuch N, Jaziri H, Brahem A, Ajmi S, Ben Slama A, Jmaa A. Maladies auto-immunes associées à la cholangite biliaire primitive (à propos de 36 cas). Rev Med Interne 2018 p : A103–A235.
- [3] Chouqui N, Boussaeden A, Benelbarhdadi I, Essamri O, Ajana F, Afifi R, Benazouz M, Essaid A. Profil épidémiologique et clinique de la cirrhose biliaire primitive au Maroc congrès francophone de référence des maladies et cancers de l'appareil digestif Paris 2009 ; France.
- [4] Gu E, Yao G. The clinical characteristics of primary biliary cirrhosis in China: a systematic review. Zhonghua Gan Zang Bing Za Zhi 2009 Nov; 17(11):861–6.